

Otoimmün Hepatit

Çocukluk çağı otoimmün hepatitinde otoantikor/IgG temelli tanı, MRCP ile ASC dışlaması ve dozlu immünsupresyon protokolü. Tanı, tedavi ve remisyon izlemi için pratik karar aracı.

Otoantikor + IgG

Prednizolon + Azatiyoprin

MRCP / ASC

Biyopsi

01 Tanım ve İlk Değerlendirme

Otoimmün hepatit (OİH), karaciğere yönelik kaybolan immün toleransla giden, karakteristik otoantikorlar, yüksek IgG ve interface hepatit ile seyreden progresif kronik hepatittir. Çocuklarda iki tip: Tip 1 (ANA ve/veya ASMA pozitif) ve Tip 2 (anti-LKM1 ve/veya anti-LC1 pozitif). Ayırıcı tanıda otoimmün sklerozan kolanjit (ASC) mutlaka dışlanmalıdır; bu nedenle her yeni tanıda MRCP zorunludur.

Öykü

- Sinsi halsizlik, iştahsızlık, sarılık; %30-40 akut hepatit tablosu, nadiren fulminan yetmezlik
- Eşlik eden otoimmün hastalık (tiroidit, çölyak, tip 1 DM, vitiligo, JİA, İBH)
- Ailede otoimmün hastalık öyküsü
- İlaç/toksin, viral hepatit, Wilson öyküsünün dışlanması
- Kronik ishal/kanlı gaita (İBH-ASC birlikteliği açısından)

Muayene

- Hepatomegali, splenomegali, ikter
- Kronik karaciğer hastalığı bulguları: spider anjioma, palmar eritem, kaput meduza
- Asit, ödem, ensefalopati (ileri evre/dekompansasyon)
- Büyüme geriliği, gecikmiş puberte
- Eşlik eden otoimmünitenin cilt/tiroid bulguları

Başlangıç tetkiki: AST/ALT, GGT, ALP, total/direkt bilirubin, albümin, INR/PT, tam kan sayımı; IgG ve total protein; ANA, ASMA, anti-LKM1, anti-LC1, atipik p-ANCA; viral seroloji (HAV, HBV, HCV, EBV, CMV), seruloplazmin/24 saatlik idrar bakır, alfa-1 antitripsin, çölyak serolojisi.

Çocukta düşük titreler bile anlamlıdır: ANA/ASMA için $\geq 1/20$, anti-LKM1 için $\geq 1/10$ pozitif kabul edilir (erişkinde eşik 1/40). Antikor negatifliği tanıyı dışlamaz (seronegatif OİH); IgG yüksekliği ve histoloji belirleyicidir.

Tip 1 OİH

- ANA ve/veya ASMA (anti-aktin) pozitif
- Genelde daha büyük çocuk/adölesan
- Sıklıkla ASC ile örtüşür → MRCP kritik

Tip 2 OİH

- Anti-LKM1 ve/veya anti-LC1 pozitif
- Küçük yaş, daha akut/şiddetli seyir
- Daha yüksek fulminan yetmezlik riski

IgG / Total IgG

- Yaşa göre üst sınırın üstünde IgG tanısız
- Tedavi yanıtı ve remisyon izleminde kullanılır
- Tip 2'de IgG normal olabilir

Atipik p-ANCA

- Tip 1 OİH ve ASC'de sık pozitif
- Kolanjiyopati şüphesini artırır

Histoloji

- Interface hepatit, portal plazma hücre infiltrasyonu
- Rozet oluşumu, emperipolez
- Fibroz/siroz evresi belirlenir

ASC Örtüşmesi

- Çocuk OİH'inin ~%50'sinde safra yolu tutulumu
- MRCP ile intra/ekstrahepatik düzensizlik
- Tedaviye UDCA eklenir

ANA/ASMA $\geq 1/20$ anti-LKM1 $\geq 1/10$

IgG ↑

Viral/Wilson dışlandı

Interface hepatit

03 Karar Akışı

Kolestatik karaciğer enzim yüksekliği + otoantikor/IgG pozitifliğinden tanı ve tedaviye giden karar ağacı.

BAŞLANGIÇ

Açıklanamayan transaminaz yüksekliği

Kronik/akut hepatit tablosu; viral, metabolik (Wilson, A1AT) ve ilaç nedenleri dışlandı.

ADIM 1

Otoantikor + IgG + tam panel

ANA, ASMA, anti-LKM1, anti-LC1, atipik p-ANCA, yaşa göre IgG.

KARAR 1

Otoantikor pozitif ve/veya IgG yüksek mi?

Çocukta düşük titre eşikleri geçerli.

EVET → Tanı doğrulama

HAYIR → Seronegatif olasılığı

ADIM 2

Karaciğer biyopsisi + MRCP

Histoloji ile interface hepatit teyidi; MRCP ile safra yolu değerlendirmesi (ASC?).

ALTERNATİF

Yine de biyopsi düşün

Klinik güçlüyse seronegatif OİH için histoloji ve IgG dışı belirteçlerle değerlendir; diğer etiyolojileri gözden geçir.

KARAR 2

Fulminan yetmezlik / ciddi ensefalopati var mı?

INR yüksek, hepatik ensefalopati, hızlı kötüleşme.

EVET → Acil

HAYIR → Standart indüksiyon

KRİTİK

Nakil merkezi + yüksek doz steroid

Karaciğer nakli değerlendirmesiyle eş zamanlı IV steroid; yanıtızlıkta transplantasyon planı.

TEDAVİ

Prednizolon indüksiyonu ± azatiyoprin

Remisyon indüksiyonu başlat; ASC varsa UDCA ekle. İdame ve doz azaltımı ile devam.

Tanıyı doğrulayan ve ASC'yi dışlayan basamaklı tetkik planı.

OİH tanı basamakları		
BASAMAK	TEST / İÇERİK	NOT
1. Biyokimya	AST, ALT, GGT, ALP, bilirubin, albümin, INR/PT	Hepatoselüler vs kolestatik ayrımı; INR/albümin sentetik fonksiyon
2. İmmünoloji	ANA, ASMA, anti-LKM1, anti-LC1, atipik p-ANCA, yaşa göre IgG	Tip 1 / Tip 2 ayrımı; düşük titre eşikleri (ANA/ASMA $\geq 1/20$, LKM1 $\geq 1/10$)
3. Dışlama	HAV/HBV/HCV/EBV/CMV serolojisi, seruloplazmin + 24 saatlik idrar bakır, A1AT, çölyak serolojisi	Viral, Wilson, A1AT eksikliği ve çölyak dışlanır
4. Histoloji	Perkütan karaciğer biyopsisi	Interface hepatit, plazma hücreleri, emperipolez, fibroz evresi
5. Kolanjiyografi	MRCP (her yeni tanıda)	ASC dışlaması; safra yolu düzensizlik/darlık → örtüşme sendromu
6. Skorelama	Pediyatrik OİH tanı kriterleri (ESPGHAN)	Antikor + IgG + histoloji + kolanjiyografi bütünleştirilir

Acil müdahale ve nakil değerlendirmesi gerektiren bulgular.

- INR $\geq 1,5-2$ ve/veya koagülopati (K vitaminine yanıtız)

- Fulminan karaciğer yetmezliğı (özellikle Tip 2)

- Dekompanse siroz: asit, varis kanaması

- MRCP'de yaygın safra yolu darlığı (ilerlemiş ASC)

- Hepatik ensefalopati / bilinç değışikliğı

- Hızlı yükselen bilirubin ve düşen transaminaz + kötüleşen sentetik fonksiyon

- Standart immünsupresyona 2 haftada yanıtızlık

- Ağır sitopeni (azatiyoprin toksisitesi / hipersplenizm)

Standart yaklaşım prednizolon indüksiyonu, erken azatiyoprin eklenmesi ve kademeli steroid azaltımıdır. Amaç: transaminazların ve IgG'nin normalizasyonu (biyokimyasal remisyon).

OİH immünsupresyon protokolü		
İLAÇ / BASAMAK	DOZ	NOT
Prednizolon (indüksiyon)	1-2 mg/kg/gün (maks 40-60 mg/gün)	Genellikle 2 mg/kg ile başlanır; transaminaz düşüşüne göre 4-8 haftada kademeli azaltım
Prednizolon (idame)	2,5-5 mg/gün (bireysel titrasyon)	En düşük etkin doza inilir; remisyonda kesme denenebilir
Azatiyoprin	1-2 mg/kg/gün (maks ~100-150 mg/gün)	Genelde 0,5 mg/kg ile başlanıp yanıt/toksositeye göre artırılır; başlamadan önce TPMT ve transaminaz kontrolü
Budesonid (alternatif)	3 mg × 3/gün (siroz YOKSA)	Sirotik olmayan, akut olmayan olgularda steroid yan etkisini azaltmak için; Tip 2 ve akut ağır olguda önerilmez
UDCA (ASC varsa)	15-20 mg/kg/gün	Örtüşme sendromunda immünsupresyona eklenir
MMF (2. basamak)	20 mg/kg/doz × 2/gün (maks ~1 g × 2/gün)	Azatiyoprin intoleransı/yanıtsızlığında; TPMT düşükse tercih

Biyokimyasal remisyon: transaminazlar ve IgG normal. Remisyon en az 12 ay ve tercihen kontrol biyopsisiyle histolojik iyileşme sağlandıktan sonra ilaç kesimi (relaps riski nedeniyle azaltarak) değerlendirilir. Tip 2 OİH'de relaps riski yüksektir, uzun süreli idame gerekebilir.

Azatiyoprin başlamadan TPMT bakılmalı; miyelosupresyon, hepatotoksisite ve pankreatit açısından ilk haftalarda sık hemogram/transaminaz izlemi yapılır. Steroid altında büyüme, kemik yoğunluğu ve glisemi izlenir.

07 İzlem / Yönetim İlkeleri

Uzun süreli izlem remisyonun sürdürülmesi, ilaç toksisitesi ve ASC progresyonuna odaklanır.

Rutin İzlem

- İlk aylarda 1-2 haftada bir, sonra aylık; stabil remisyonunda 3 ayda bir transaminaz + IgG
- Hemogram ile azatiyoprin toksisitesi takibi
- Relapsta doz artırımı; tekrarlayan relapsta 2. basamak tedavi
- ASC varsa periyodik GGT/ALP ve gerektiğinde MRCP tekrarı

Destek ve Güvenlik

- Uzun süreli steroidde büyüme, kemik sağlığı (D vitamini/kalsiyum), göz (katarakt) izlemi
- Canlı aşı öncesi immünsupresyon düzeyi değerlendirmesi; inaktif aşılar önerilir
- İlaç uyumu ve adölesan geçiş (transition) planlaması
- Dekompansasyon/nakil kriterlerinin ailece bilinmesi

Kaynaklar

1. Mieli-Vergani G, et al. Diagnosis and Management of Pediatric Autoimmune Liver Disease: ESPGHAN Hepatology Committee Position Statement. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2018;66(2):345-360.
2. European Association for the Study of the Liver (EASL). Clinical Practice Guidelines on the management of autoimmune hepatitis. J Hepatol. 2015 / 2023 güncellemesi.
3. Mack CL, et al. Diagnosis and Management of Autoimmune Hepatitis in Adults and Children: AASLD Practice Guidance. Hepatology. 2020;72(2):671-722.
4. Di Giorgio A, et al. Seamless management of juvenile autoimmune liver disease. Review. 2020.

Uyarı: Bu belge pediyatrik gastroenteroloji/hepatoloji uzmanları için hazırlanmış bir klinik karar destek aracıdır; hasta bazında klinik yargı, güncel kılavuzlar ve yerel protokollerin yerine geçmez. Dozlar hastaya göre

bireyselleřtirilmeli ve doęrulanmalıdır.